

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos de conducta y oposicionistas** (TDO y TC) son **trastornos del comportamiento disruptivo**, caracterizados por **patrones persistentes de desafío a la autoridad, hostilidad, agresividad y violación de normas sociales o derechos de otros**.

Representan una de las causas más frecuentes de consulta en pediatría, salud mental infanto-juvenil y contexto escolar.

Relevancia clínica:

- **Prevalencia:** 3–5% en población infantil y adolescente.
- **Inicio:** entre los 6–10 años, más precoz en varones.
- **Alta comorbilidad:** con TDAH (50%), trastornos del ánimo, ansiedad y consumo de sustancias.
- **Pronóstico funcional:** si no se trata adecuadamente, puede evolucionar hacia **trastorno disocial** o incluso **trastorno antisocial de la personalidad** en la adultez.

En Chile, estos cuadros son motivo frecuente de **derivación desde colegios, tribunales de familia y programas de protección de la infancia (SENAME, SENDA, COSAM)**.

- En el **EUNACOM**, suelen plantearse casos de niños agresivos, desafiantes o con problemas escolares persistentes, donde se espera reconocer el diagnóstico y establecer un manejo integral (conductual + familiar + escolar).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **trastorno oposicionista desafiante (TDO)** y el **trastorno de conducta (TC)** pertenecen a un **continuum** de alteraciones del control de impulsos y regulación emocional.

2.1. Bases neurobiológicas

- **Disfunción frontoestriatal:** menor actividad en la **corteza prefrontal ventromedial**, responsable del control de impulsos y la empatía.

- **Alteración dopaminérgica y serotoninérgica**, asociada a impulsividad y agresividad.
- **Elevada reactividad del sistema límbico (amígdala)** frente a estímulos frustrantes.

2.2. Factores psicosociales y ambientales

- **Crianza autoritaria o inconsistente** (alternancia entre sobrecontrol y negligencia).
- **Violencia intrafamiliar o abuso físico / emocional.**
- **Ambientes desestructurados, pobreza, consumo parental de sustancias.**
- **Rechazo escolar o social precoz.**

□ Estos factores no son causas únicas, sino **potenciadores** en individuos vulnerables genéticamente. La interacción entre temperamento difícil y entorno adverso es determinante.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Trastorno Oposicionista Desafiante (TDO)

Definición:

Patrón persistente (≥ 6 meses) de **conductas negativistas, hostiles y desafiantes** hacia figuras de autoridad, **sin violar normas o derechos de otros**.

Síntomas característicos (DSM-5):

Debe cumplir al menos **4 de los siguientes**, presentes con al menos un individuo no familiar:

- Se enoja con facilidad, pierde el control.
- Discute con adultos o figuras de autoridad.
- Desafía reglas o rehúsa cumplir instrucciones.
- Molesta deliberadamente a otros.
- Culpa a los demás por sus errores o mala conducta.
- Es irritable o rencoroso.

Evolución:

- Suele comenzar en **edad preescolar o escolar temprana**.
 - Muchos casos mejoran con intervenciones conductuales.
 - Un subgrupo evoluciona hacia **Trastorno de Conducta** en la adolescencia.
-

3.2. Trastorno de Conducta (TC)

Definición:

Patrón repetitivo y persistente de **conductas antisociales y violatorias de normas o derechos**, con impacto funcional severo.

Criterios diagnósticos (DSM-5):

Presencia de **≥3 de los siguientes en los últimos 12 meses**, con al menos 1 en los últimos 6 meses:

1. **Agresión a personas o animales:** pelea, crueldad física, uso de armas.
2. **Destrucción de propiedad:** incendios, vandalismo.
3. **Fraude o robo:** mentiras, hurtos, estafas.
4. **Violación grave de normas:** escaparse de casa, ausentismo escolar, trasnocharse sin permiso.

Subtipos según edad de inicio:

Tipo	Inicio	Características
Infantil (antes de 10 años)	Más grave, peor pronóstico.	Agresividad temprana, co-ocurre con TDAH.
Adolescente (≥10 años)	Más leve.	Conductas grupales, asociadas a pares.

No especificado

Edad incierta o diagnóstico incompleto.

Conducta antisocial sin suficiente información.

3.3. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
TDAH	Inatención e impulsividad, sin violación deliberada de normas.
Trastorno explosivo intermitente	Episodios breves de ira, sin patrón persistente de desafío.
Trastorno del ánimo	Conducta irritable secundaria a depresión o bipolaridad.
Trastorno del espectro autista	Rigidez y rabietas por frustración, no por desafío.
Trastorno disocial o antisocial adulto	Conductas criminales persistentes, sin remordimiento.

☐ La **intencionalidad** es clave: en TDO la conducta es reactiva; en TC, es planificada o instrumental.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**, basado en la observación longitudinal, historia familiar y escolar, y entrevistas con los cuidadores.

4.1. Evaluación estructurada

- **Entrevista clínica infantil** (niño y padres).

- **Observación conductual en distintos contextos.**
- **Escalas y cuestionarios:**
 - **Conners o SNAP-IV** (útiles para comorbilidad con TDAH).
 - **Child Behavior Checklist (CBCL).**
 - **Inventario de Conducta de Achenbach.**

4.2. Exámenes complementarios

Solo si hay sospecha de:

- **Retraso cognitivo o dificultades de aprendizaje** → derivar a evaluación psicopedagógica.
- **Abuso de sustancias o daño orgánico cerebral** → exámenes específicos.
- **Comorbilidad psiquiátrica** → evaluación por psiquiatría infantil.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento debe ser **integral, coordinado y familiar**, combinando abordaje conductual, psicoeducación, apoyo escolar y farmacoterapia solo si es necesario.

5.1. Intervenciones psicoeducativas y conductuales (primera línea)

1. Psicoeducación familiar

- Explicar que se trata de un trastorno del control emocional, no mera “mala crianza”.
- Educar sobre la importancia del **refuerzo positivo** y las **consecuencias consistentes**.
- Evitar castigos físicos o gritos (aumentan la agresividad).
- Favorecer la **comunicación estructurada** y límites claros.

2. Entrenamiento parental

Programas basados en evidencia:

- **Triple P (Positive Parenting Program).**
- **Parent Management Training (PMT).**
- **Incredible Years.**

Objetivo: mejorar estrategias de manejo conductual y promover vínculos seguros.

3. Intervención conductual individual

- Terapia cognitivo-conductual (TCC): identificación de emociones, resolución de conflictos, control de impulsos.
- Entrenamiento en habilidades sociales y empatía.
- Reforzar conducta prosocial en escuela.

4. Coordinación con el sistema escolar

- Incluir en **Programa de Integración Escolar (PIE).**
- Establecer **contratos conductuales** con refuerzos positivos.
- Asegurar comunicación bidireccional con el equipo de salud.

5.2. Abordaje farmacológico

El tratamiento farmacológico **no es de primera línea**, pero puede indicarse si:

- Hay **comorbilidad con TDAH, ansiedad o depresión.**
- Conductas agresivas severas que impiden intervención conductual.
- Riesgo de daño físico hacia sí mismo u otros.

Opciones farmacológicas:

Situación	Fármaco sugerido	Comentarios
-----------	------------------	-------------

TDO / TC con TDAH	Metilfenidato	Mejora control de impulsos.
Agresividad grave / irritabilidad	Risperidona (atípico)	Eficaz a corto plazo; vigilar efectos metabólicos.
Impulsividad con ansiedad	ISRS o atomoxetina	Si hay síntomas internalizantes.
Trastorno explosivo intermitente	Valproato / carbamazepina	En casos refractarios.

□ Según **MINSAL Chile**, el manejo debe priorizar intervenciones psicosociales. La medicación se reserva para casos moderados a graves y bajo supervisión psiquiátrica.

5.3. Intervención comunitaria y derivación

- Derivar a **COSAM** o **equipo de salud mental infanto-juvenil** si:
 - Conducta violenta o riesgo para terceros.
 - Fracaso de manejo en APS.
 - Comorbilidad psiquiátrica.
- En casos judicializados o con vulneración de derechos: coordinación con **tribunales de familia / SENDA / OPD**.
- En adolescentes con consumo de drogas: derivación a **Programa Ambulatorio Intensivo (PAI)**.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Fracaso escolar, expulsiones repetidas.

- Rechazo social y aislamiento.
- Accidentes y conductas de riesgo.
- Consumo de alcohol y drogas.
- Trastornos depresivos y suicidio en adolescencia.
- Evolución hacia **trastorno disocial o antisocial** en la adultez.

6.2. Pronóstico

Depende de:

- **Edad de inicio:** más precoz = peor pronóstico.
- **Comorbilidades:** TDAH, abuso de sustancias, disfunción familiar.
- **Acceso a intervención temprana.**
- **Nivel de apoyo parental y escolar.**

☐ Con tratamiento integral, hasta un **60–70% mejora significativamente** en conducta y rendimiento social en 2–3 años.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas clínicas

1. El TDO se caracteriza por **desafío e irritabilidad**, sin violación de derechos.
2. El TC incluye **conductas antisociales activas** (robo, agresión, vandalismo).
3. **TDAH y TDO** coexisten frecuentemente y deben tratarse en conjunto.
4. La **psicoeducación y entrenamiento parental** son primera línea de tratamiento.
5. Los **antipsicóticos atípicos (risperidona)** pueden usarse para controlar agresividad grave.

6. Evitar etiquetar al niño como “malo” o “sin remedio”: el estigma empeora el cuadro.
 7. El **diagnóstico es clínico**; no se requieren exámenes para confirmarlo.
 8. La **coordinación entre salud, educación y familia** es esencial para el éxito terapéutico.
-



Errores comunes

- Confundir TDO con problemas de crianza o indisciplina.
 - Indicar fármacos sin intervención familiar previa.
 - No pesquisar TDAH o comorbilidades emocionales.
 - Aplicar castigos severos o expulsar al niño del sistema escolar.
 - Falta de continuidad en el seguimiento entre salud y educación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **trastornos oposicionistas y de conducta** son cuadros del **neurodesarrollo y la regulación emocional**, no simples problemas de comportamiento.
2. El **TDO** implica desafío y negativismo; el **TC**, agresión y violación de normas.
3. El diagnóstico es **clínico y evolutivo**, basado en conducta persistente en distintos contextos.
4. El tratamiento es **multidisciplinario**, centrado en **psicoeducación, entrenamiento parental y coordinación escolar**.
5. Los **fármacos** (metilfenidato, risperidona) son coadyuvantes en casos moderados o graves.
6. La **detección y derivación precoz** al COSAM o psiquiatría infantil mejora el pronóstico.

7. En EUNACOM, el enfoque esperado es **empático, educativo y preventivo**, no punitivo.